

平潭综合实验区社会事业局文件

岚社会医保〔2022〕39号

平潭综合实验区社会事业局关于印发 《紧密型县域医共体医保基金打包 支付绩效考核实施方案》的通知

区行政服务中心、区总医院：

现将《平潭综合实验区紧密型县域医共体医保基金打包支付绩效考核实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到问题请及时反馈。

平潭综合实验区社会事业局

2022年12月12日



平潭综合实验区紧密型县域医共体 医保基金打包支付绩效考核实施方案

为积极稳妥推进县域医共体建设，加强医保服务管理，建立科学的绩效考核办法和评价指标体系，引导医共体进一步提高医疗服务质量和效率，根据平潭综合实验区社会事业局 平潭综合实验区财政金融局《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体医保基金打包支付方案（试行）的通知》（岚社会医保〔2022〕38号）精神，结合实验区实际，制定本方案。

一、考核时间

实施年度集中考核，原则上于次年3月底前完成。

二、考核内容及形式

根据县域医共体管理服务情况，坚持目标和问题导向，逐步健全完善县域医保基金打包支付绩效考核指标体系，由医保部门、卫健部门按照《平潭县域医共体医保基金打包支付方式改革绩效考核指标体系表（试行）》（详见附件），联合开展县域医共体医保基金打包支付绩效考核工作，主要包括综合管理、分级诊疗、费用控制、健康管理、群众满意度等考核内容。

三、考核结果运用

年度绩效考核结果与打包基金年度结算比例和合理超支分担比例等医保基金支付结算挂钩。按照“结余留用、合理超支分担”的原则，分别结算城镇职工和城乡居民基本医保基金，结余的医保打包基金可纳入医共体的医疗服务性收入，按规定提取各项基金后，主要用于医共体内人员薪酬或奖励。

（一）做好年度结算工作。医保经办机构于次年第一季度前，先按当年度实际参保人数确定医保基金打包总额，扣减重复参保人员的财政补助部分后，再根据绩效考核结果，分三档进行结算：考核等次为优秀的，年度打包基金按 100% 结算；考核等次为良好的，年度打包基金按 99.5% 结算；考核等次为一般的，年度打包基金按 99% 结算（具体考核等次对应分值详见附件）。

（二）实施合理超支分担。对年度内实际发生的统筹基金支出总额超过医保基金打包总额的部分，医保部门按考核等次优秀、良好、一般和超支比例分段进行超支分担，分担总额不超过县域提取的历年风险调节金总额。如下表：

考核等次	超支金额	医共体分担比例	医保基金分担比例
优秀	在医保基金打包总额 10%(含) 以内的部分	50%	50%
	在医保基金打包总额 10%(不含) — 20%(含) 的部分	75%	25%
	超过医保基金打包总额 20%(不含) 以上的部分	100%	0%
良好	在医保基金打包总额 10%(含) 以内的部分	55%	45%
	在医保基金打包总额 10%(不含) — 20%(含) 的部分	80%	20%
	超过医保基金打包总额 20%(不含) 以上的部分	100%	0%
一般	在医保基金打包总额 10%(含) 以内的部分	60%	40%
	在医保基金打包总额 10%(不含) — 20%(含) 的部分	85%	15%
	超过医保基金打包总额 20%(不含) 以上的部分	100%	0%

附件

平潭县域医共体医保基金打包支付方式改革绩效考核指标体系表（试行）

一级指标	二级指标	标准分	指标说明	评分标准	评分
综合管理 (16分)	医共体内部管理制度建设与落实情况	6	制定总医院章程、建立内部组织机构管理和议事规则，健全内部决策管理制度、基层人才引进培养机制、财务审计管理制度、绩效考核制度等，并落实到位	查看文件资料，缺一项扣1分。	
	医共体药品耗材管理情况	4	建立和完善医共体药品耗材采购制度，实行医共体内统一用药目录，积极跟进药品耗材采购改革，按要求支付医保经办机构代垫的药械结算款项。	查看文件资料，缺一项扣1分。	
	医保管理情况	6	总医院要对各成员单位定期开展医保相关政策培训及检查工作，对发现的问题进行通报并督促整改到位。对医保部门考核、稽核、稽查等发现的问题，各成员单位要按要求及时整改到位。	总医院有开展医保相关政策培训得1分，有开展医保检查得1分，有进行医共体内通报得1分，奖惩责任到人得1分，反之不得分；各成员单位对医保部门考核、稽核和稽查等发现的问题未整改或整改不到位的，每次扣1分，最多扣2分。	
	患者有序转诊	6	组织实施基层常见病、多发病防治指南，明确县域医共体内县、乡两级疾病诊疗目录，建立完善医共体内部、医共体之间转诊管理办法。	查看文件资料，有组织实施基层常见病、多发病防治指南得1分，有制定医共体内部、医共体之间转诊管理规范得1分，有建立县级和乡镇疾病诊疗目录各得2分，反之不得分。	
	县域内住院量占比	2	计算方法：县域内住院量占比=(城乡居民基本医保住院患者)在县域内住院人次数/城乡居民住院患者总人次数(含县域内和县域外)×100% 数据来源：医保信息系统	采用以下两种方式分别计分，取较高分作为该项得分。 (1)指标值≥60%（或达到当年省定目标值）得2分；低于目标值的，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。 (2)与上年值持平或增长得1.6分，每增加一个百分点加0.2分，最高2分；较上年下降得1分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	

分级诊疗 (28分)	医保基金县域内支出率	6	计算方法：医保基金县域内支出率=县域内医疗机构基金支出/全县基本医保统筹基金支出(含县域内和县域外)×100% 数据来源：医保信息系统	采用以下两种方式分别计分，取较高分作为该项得分。 (1)指标值≥50%得6分；低于目标值的，每降低一个百分点扣0.6分，扣完为止。(2)与上年值持平或增长得4.8分，每增加一个百分点加0.6分，最高6分；较上年下降得3分，每降低一个百分点扣0.6分，扣完为止。
	县域内基层医疗卫生机构诊疗量占比	8	计算方法：县域内基层医疗卫生机构诊疗量占比=县域内基层医疗卫生机构诊疗人次/县域内医疗机构总诊疗人次×100%(统计口径参照医改相关指标统计要求) 数据来源：卫生健康部门	采用以下两种方式分别计分，取较高分作为该项得分。 (1)指标值≥56.21%得8分；低于目标值的，每降低一个百分点扣0.8分，扣完为止。(2)与上年值持平或增长得6.4分，每增加一个百分点加0.8分，最高8分；较上年下降得4分，每降低一个百分点扣0.8分，扣完为止。
	高血压、糖尿病基层诊疗占比	6	计算方法：高血压、糖尿病基层诊疗占比=在县域内基层医疗机构就诊高血压、糖尿病特殊门诊的人数/所有高血压、糖尿病特殊门诊就诊人数×100% 数据来源：医保信息系统	与上年值持平或增长得4.8分，每增加一个百分点加0.6分，最高6分；较上年下降得3分，每降低一个百分点扣0.6分，扣完为止。
费用控制 (34分)	次均住院费用增幅	4	计算方法：次均住院费用增幅=(医共体当年度次均住院费用-医共体上年度次均住院费用)/医共体上年度次均住院费用×100% 数据来源：医保信息系统	城镇职工和城乡居民基本医保各占2分，分别统计。与上年值持平或下降得1.6分，每降低一个百分点加0.2分，最高2分；较上年增长得1分，每增长一个百分点扣0.2分，扣完为止。
	次均普通门诊费用增幅	8	计算方法：次均普通门诊费用增幅=(医共体当年度次均普通门诊费用-医共体上年度次均普通门诊费用)/医共体上年度次均普通门诊费用×100%(统计数据不含特殊门诊费用) 数据来源：医保信息系统	城镇职工和城乡居民基本医保各占4分，分别统计，与上年值持平或下降得3.2分，每降低一个百分点加0.4分，最高4分；较上年增长得2分，每增加一个百分点扣0.4分，扣完为止。

	住院药品耗材、 检验检查费用 占比	4	计算方法：住院药品耗材费用占比=医共体住院药品耗材费用/医共体住院医疗总费用×100% 住院检验检查费用占比=医共体住院检验检查费用/医共体住院医疗总费用×100% 数据来源：医保信息系统	药品耗材费用占比和检验检查费用占比各占2分，分别统计。采用以下两种方式分别计分，取较高分作为该项得分。(1)药品耗材费用占比≤30%(检验检查费用占比≤20%)得2分；超过目标值的，每增加一个百分点扣0.2分，扣完为止。(2)与上年值持平或下降得1.6分，每降低一个百分点扣0.2分，最高2分；较上年增长得1分，每增长一个百分点扣0.2分，扣完为止。
	按病种付费的 出院人数占比	6	计算方法：占比=医共体内县级公立综合医院和县级公立中医院按病种付费的出院参保人数/医共体内县级公立综合医院和县级公立中医院的总出院参保人数×100% 数据来源：医保信息系统	采用以下两种方式分别计分，取较高分作为该项得分。(1)指标值≥50%得6分；低于目标值的，每降低一个百分点扣0.6分，扣完为止。(2)与上年值持平或增长得4.8分，每增长一个百分点扣0.6分，最高6分；较上年下降得3分，每降低一个百分点扣0.6分，扣完为止。
	按临床路径规范管理的出院 人数占比	6	计算方法：占比=医共体内县级公立综合医院按临床路径规范管理的出院人数/医共体内县级公立综合医院总出院人数×100% 数据来源：卫健部门	采用以下两种方式分别计分，取较高分作为该项得分。(1)指标值≥50%得6分；低于目标值的，每降低一个百分点扣0.6分，扣完为止。(2)与上年值持平或增长得4.8分，每增长一个百分点扣0.6分，最高6分；较上年下降得3分，每降低一个百分点扣0.6分，扣完为止。
	目录外费用比 例	6	计算方法：(基本医保住院患者)目录外费用比例=三医共体住院非医保目录医疗费用/医共体住院医疗费用×100%(该指标仅统计住院直接刷卡时医保属性为非医保的项目费用，不统计超项目限额部分的费用。) 指标来源：医保信息系统	指标值≤8%，得6分；未达到目标值的，每提高一个百分点扣0.6分，扣完为止。
健康管理 (16分)	基本公共卫生 服务任务落实 情况	10	计算方法：按照国家基本公共卫生服务项目进行考核 数据来源：卫健部门	根据卫健部门考核结果计算该项分值，达到90分及以上的得10分；低于90分的，每减少一分扣0.5分，扣完为止。

	“两病”规范化 管理人群用药 保障	6	建立“两病”人群门诊用药保障数据台账，基层医疗机构可直接开具“两病”门诊用药保障范围内的药品。	有建立“两病”人群门诊用药保障数据台账得3分，基层医疗机构可直接开具“两病”门诊用药保障范围内的药品得3分，反之扣相应分值。	
群众满意度 (6分)	群众医疗服务 满意度	6	群众医疗服务满意度参考卫健部门的第三方满意度调查的结果，按县域内有参加第三方满意度调查的所有医疗机构成员单位的平均值统计。	指标值 $\geq 90\%$ ，得6分；未达到目标值的，每降低一个百分点的扣0.6分，扣完为止。	

备注：1. 考核分为3个等次，其中90分(含)以上为优秀，80分(含)至90分为良好，80分以下为一般。

2. 该绩效考核指标体系表是对整个县域的考核。
3. 所有绩效考核指标体系均不含生育保险和意外伤害的相关数据。
4. 对考核指标中评分标准按一个百分点(或一分)加减分数的，不足一个百分点(或一分)按比例进行折算，精确到小数点后2位数。

